

ДИЕТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ДОМАШНИЙ РАЦИОН

Специализированный бланк-задание для согласования с ветеринарным диетологом

Пациент: Рамзес (кобель, кастрирован)	Порода / Возраст: Кане-Корсо, 11 лет
Ведущая патология: Хилёзный плевральный выпот (подозрение на лимфому)	Сопутствующий диагноз: ХБП 2 стадии по IRIS (Креатинин 132-140 мкмоль/л)
Текущая терапия: Габапентин (контроль боли), Преднизолон (в составе СНОР)	Метаболический статус: Паранеопластическая гипогликемия (2,42 ммоль/л)

1. КЛИНИЧЕСКИЙ ДИЕТИЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ И РИСКИ

У пациента Рамзеса имеет место редкое сочетание двух тяжелых патологий, выдвигающих противоположные требования к питанию. Прямое использование готовых промышленных почечных кормов (Renal) или стандартных домашних диет создает высокие риски для жизни.

Патология / Требование	Определяющий механизм	Проблема стандартных рационов
Хилоторакс (Хилёзный выпот)	Длинноцепочечные жиры из пищи всасываются в лимфу ЖКТ в виде хиломикронов, повышая давление в грудном протоке и объём выпота.	Высокий жир в почечных кормах: Промышленные корма Renal содержат 18-22% жира для калорийности. Это спровоцирует критическое накопление хилуса и одышку.
ХБП 2 стадии (Почечная недостаточность)	Снижена клубочковая фильтрация. Требуется умеренное ограничение фосфора и поддержание адекватного качества белка при высокой гидратации.	Несбалансированный белок/фосфор: Обычное мясо содержит много фосфора, что ускоряет склероз нефронов и прогрессирование азотемии.
Торакоцентезы и Опухоль (Потери белка и гипогликемия)	Откачивание выпота вымывает из организма альбумин, белки, липиды и жирорастворимые витамины (А, D, Е, К). Гипогликемия требует сложных углеводов.	Безбелковая диета приведет к кахексии: Чрезмерное урезание белка вызовет гипоальбуминемию и мышечную атрофию у 11-летнего Кане-Корсо.

2. ГЛАВНЫЕ ЦЕЛИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО РАЦИОНА

1. Ультра-низкий жир (Ultra Low-Fat): Исключение всех видимых жиров и масел. Суммарная жирность рациона должна быть строго минимальной (< 10% в пересчете на сухое вещество) для снижения лимфотока.
2. Постный высокоусвояемый белок: Использование куриной грудки без кожи, обезжиренного творога (≤2%) и яичного белка для восполнения потерь альбумина без нагрузки на почки.
3. Фосфорный контроль и биндеры: Введение карбоната кальция (CaCO₃) как обязательной добавки, связывающей фосфор в кишечнике и обеспечивающей кальциевый баланс.
4. Нутрицевтическая поддержка (Рутин): Введение перорального флавоноида Рутина (Rutin) для стимуляции фагоцитоза липидов выпота макрофагами и снижения проницаемости сосудов.
5. Замещение витаминных потерь и гидратация: Дополнительное введение жирорастворимых витаминов (А, D, Е, К) и постоянный свободный доступ к свежей питьевой воде.

3. БАЗОВАЯ СТРУКТУРА И ИНГРЕДИЕНТЫ ДОМАШНЕГО РАЦИОНА

Категория	Рекомендуемые продукты	Запрещенные продукты	Цель использования
Источники белка (Ultra Low-Fat)	- Отварное куриное филе (без кожи) - Обезжиренный творог (0–2%) - Яичный белок (вареный) - Консервированный тунец в собств. соку	- Жирное мясо (говядина, свинина, баранина) - Кожа птицы, субпродукты - Жирные сыры и творог > 2%	Восполнение потерь белка и альбумина с выпотом при минимальной жировой нагрузке.
Углеводная база (Энергия и Гипогликемия)	- Вареный белый рис - Отварной картофель (без кожи) - Овсяная каша на воде	- Простые сахара - Жирные каши на бульоне - Лакомства со стола	Обеспечение калорийности за счет сложных углеводов, стабилизация глюкозы (2,42 ммоль/л).
Минералы и Биндеры	- Карбонат кальция (CaCO₃ / мел мелкий пищевой) - Цитрат кальция (по назначению)	- Костная мука (высокий фосфор) - Витаминно-минеральные смеси с фосфором	Связывание фосфора пищи в ЖКТ и нормализация Ca:P соотношения при ХБП Stage 2.
Нутрицевтики и Витамины	Рутин (Rutin): 500 мг 1-2 р/день - Комплекс витаминов А, D, Е, К - Витамины группы В	- Растительные масла (оливковое, лососевое) - Жировые эмульсии и МСТ-масла	Снижение проницаемости лимфатических сосудов и восполнение вымываемых витаминов.

4. ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ШАБЛОН СУТОЧНОЙ ПОРЦИИ (ДЛЯ РАСЧЕТА ДИЕТОЛОГОМ)

Базовое объёмное соотношение ингредиентов: 1 часть углеводной базы : 1 часть постного белка

Примерный суточный набор (требует адаптации под весовой граммаж):

- Углеводный компонент:** 1–1.5 чашки отварного белого риса или отварного картофеля.
- Белковый компонент:** 1 чашка отварного куриного филе (без кожи) или обезжиренного творога (2%).
- Минеральный фосфат-биндер:** ½ чайной ложки карбоната кальция (CaCO₃) тщательно перемешать с порцией.
- Целевой нутрицевтик:** Рутин (Rutin) 500 мг перорально во время кормления.
- Водный режим:** Свободный доступ к фильтрованной воде 24/7.

5. ЧЕК-ЛИСТ ВОПРОСОВ И ЗАДАЧ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ДИЕТОЛОГА

[]	Расчет точной суточной калорийности (Kcal) и белка (г/kg): Рассчитать энергетическую потребность с учетом массы тела Рамзеса, возраста (11 лет) и потерь белка при торакоцентезах.
[]	Точный расчет дозы CaCO₃: Пересчитать граммаж карбоната кальция на суточную норму сырого/варёного мяса для достижения целевого соотношения Ca:P = 1.3:1 – 1.5:1.
[]	Коррекция витаминов А, D, Е, К: Подобрать аптечный или ветеринарный водорастворимый/эмульгированный витаминный комплекс для восполнения потерь с лимфой.
[]	Согласование применения Рутина: Уточнить суточную дозировку Рутин (Бензопирона) и продолжительность курса для снижения объёма хилоторакального выпота.
[]	План лабораторного контроля: Запланировать повторную биохимию крови (Креатинин, Мочевина, Фосфор, Альбумин, Кальций) через 14 дней после старта домашней диеты.

⚠ **ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦА И ВРАЧА:**

При любом нарастании частоты дыхательных движений во сне (ЧДД > 30–35 в минуту), появлении одышки или отказе от воды более 12–24 часов необходимо немедленно связаться с лечащим врачом-онкологом или приехать в клинику для проведения разгрузочного торакоцентеза!